

AMAURI EMBOAVA DE ARAUJO	
HD:	
MEDICO:	
MEDICAMENTOS:	
IMC	
CIRCUNF. DE PESCOÇO	IAH = 37.7 e/h
PA:	
OXIMETRIA:	
P: 10.5	
Fuga: 24.2	
IAH = 5.4/h	fua
13/13 P: 10.6	
22 Fuga: 10.8	
4.7.	fua
12 P: 10.4	
01 IAH: 2.9	
22 M. de uso: 5h14	fua
18/03 P: 10.6	
22 IAH: 1.8/h	
M de uso: 5hr	fua
30/06 P: 10.6	
22 IAH: 1.5/h	
M. de uso: 3h32'	fua
04/11 P: 10.1 cmH ₂ O	
22 IAH: 1.5/h	
M. de uso: 4h19'	
Bem adaptado	fua
11/01 P: 9.8	- aparelho q barulho
23 IAH: 0.2/h	devido umidif.
M. de uso: 2h30'	- masc. q oxi-sil
	fua
02/02 P: 9.2	
24 M. de uso: 3h15'	
IAH: 1.4 e/h	
Fuga: 20.4 l/min	fua

04/03 P = 9.1 cmH₂O Bem adaptado
24 Fuga = 4.3 lpm
IAH = 1.1 elev

04/11 P = 8.6 cmH₂O Bem adapt.; relata que a
24 IAH = 0.8 elev masc. equilibrou.
m. de uso = 4hr
fuga = 9.6 lpm Juca

03/02 P = 8.6 cmH₂O Relata que está utilizando
25 IAH = 1.1 30 d - 24 d
m. de uso: 4hr Ana

17/03/25 P = 8.8 cmH₂O Bem adaptado
IAH = 0.8 elev
m. de uso: 6 h 5' Matarica

19/05 P = 8.3 cmH₂O Bem adapt.
25 IAH = 1.0 elev
m. de uso: 5h
fuga = 11.7 lpm.
Juca Claudio

Amauri emboava de Araujo

À EMPRESA DE CPAP

PACIENTE COM RNCOS E APNÉIA, SEM MELHORA COM
TRATAMENTO CLÍNICO

POLISSONO

IAH - 37,7 ✓

IAH DURANTE SONO REM - 53/H

NADIR 82%

SAT MED 92%

MICRO DESPERTARES 21,8/H

SOLICITO ADAPTAÇÃO PARA CPAP AUTOMÁTICO EM
RAMPA, COM UMIDIFICADOR E CARTÃO DE LEITURA

CID: G47.3

Dr. Luiz Antonio da Silveira
Clínica Médica
CRM - 40.263 - RQE: 38744

Dra. Marina Leite da Silveira
Dermatologista
CRM 130.637 / RQE: 36404

Dr. Mateus Francisco S. Libardi
Ortopedia e Traumatologia
Especialista em Joelho
CRM - 143.110 / TEOT: 13337
RQE: 49194

Dra. Priscila Leite da Silveira
Otorrinolaringologista
CRM - 140.497 / RQE: 40311

Dra. Priscila L. Silveira
Otorrinolaringologista
CRM 140.497

Nome: AMAURI EMBOAVA DE ARAUJO
Data de Nascimento: 20-7-1965
IMC: 31,67
Sexo: Masculino
Data do exame: 28-10-2021

Peso: 97 kg
Altura: 1,75 m
Médico: DR. PRISCILA LEITE DA SILVEIRA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 28-10-2021, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 502,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 52,0 e 74,0 minutos. O tempo total de sono foi de 377,5, eficiência de 75,1% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,6%; estágio N2: 64,4%; estágio N3: 15,9%; sono REM: 17,1%. O índice de despertares foi de 21,8/hora (normal < 10/h).

O índice de apnéia/hipopnéia total foi de 37,7/hora, sendo elas 13 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 198 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e mínima de 82%, permanecendo 3,5% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 52 - 79 bpm e NREM de 51 - 86 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (15), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 37,7/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=82%);
5. latência para o sono aumentada e latência para o sono REM diminuída;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco moderado durante o sono.

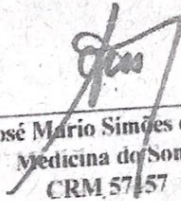
Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

O
A ELZA, 418, VILA ADYANA
1-1001 / 99724-7053

VITAL AIRE
RUA PARAIBUNA, 811, SALA 1402
TEL - 3341-9008

os médicos

CEP: 12243-770 - contato@silveirasjc.med.br
Teis: (12) 3922-6109 / 3917-9828 / 98866-6109

Amauri emboava de Araujo

À EMPRESA DE CPAP

PACIENTE COM RONCOS E APNÉIA, SEM MELHORA COM
TRATAMENTO CLÍNICO

POLISSONO

IAH - 37,7

IAH DURANTE SONO REM - 53/H

NADIR 82%

SAT MED 92%

MICRO DESPERTARES 21,8/H

SOLICITO ADAPTAÇÃO PARA CPAP AUTOMÁTICO EM
RAMPA, COM UMIDIFICADOR E CARTÃO DE LEITURA

CID: G47.3

Dra. Priscila L. Silveira
Análise de dados
Sala 1402